

Cribado de riesgo suicida en sesión

Guía de conversación directa, sin rodeos ni miedo

Preguntar directamente sobre ideación suicida no aumenta el riesgo — la evidencia muestra lo contrario. Evitar preguntar de forma directa, por miedo a “ponerlo en la cabeza” del paciente, retrasa la detección de un riesgo que ya podía estar presente.

ESCALERA DE PREGUNTAS

1. Ideación

“¿En este tiempo tuviste pensamientos de que no vale la pena seguir, o de no querer estar más?”

2. Frecuencia

“¿Con qué frecuencia aparecen esos pensamientos? ¿Podés dejarlos de lado o se imponen?”

3. Plan

“¿Has llegado a pensar en cómo lo harías?”

4. Intención

“¿Sentís que podrías llegar a hacerlo?”

5. Acceso a medios

“¿Tenés acceso a aquello con lo que lo harías?”

6. Antecedentes

“¿Alguna vez intentaste algo antes?”

QUÉ HACER SEGÚN EL NIVEL DE RESPUESTA

NIVEL	ACCIÓN
Ideación pasiva, sin plan	Profundizar seguimiento, reforzar red de apoyo, citar en plazo breve, psicoeducar a la familia si corresponde.
Ideación activa, sin plan concreto	Evaluación de riesgo más exhaustiva en la misma sesión, considerar interconsulta psiquiátrica.
Plan + acceso a medios + intención	Derivación urgente / guardia. No dejar al paciente solo. Activar red de contención inmediata.

■ Clave clínica

Documentar siempre la evaluación realizada, incluso cuando el riesgo sea bajo.

Argentina: línea 135 (CABA/GBA) o 0800-345-1435 (todo el país), 24 hs.

Línea nacional de Salud Mental: 0800-999-0091.